

Liver MRI review

Preliminary observation: A tiny focus in the posterior right liver appears on more than one sequence. Its appearance may represent a small fluid-containing focus, such as a cyst, but this is **not a confirmed diagnosis**. No obvious large liver mass is apparent in the reviewed images. This review cannot establish or exclude cancer.

Examination	Abdominal MRI with multiphase contrast-labelled sequences; study description includes "MRCP".
Study date / source	14 September 2026; local folder Study0914083729048. [1]
Available images	636 DICOM images in 12 series; 1.5-tesla scanner.
Clinical information	Reason for examination, symptoms, liver history, blood tests, previous scans and signed radiology report were not supplied.

Point 1: posterior right liver

A small rounded focus is bright on axial T2 images (series 3, images 8–9) and dark relative to the enhanced liver on venous-labelled T1 images (series 10, images 41–42) and delayed-labelled images (series 12, images 41–42). The apparent correspondence is based on anatomy; respiratory position changes between sequences. [1]

The focus appears **subcentimeter (under 1 cm)**. A precise diameter, Couinaud segment and enhancement measurement are not reliable from this review. A tiny cyst is a possibility, but vascular cross-sections and partial-volume effects must be excluded by the radiologist. The image plate marks this review target; it does not establish a total lesion count.

Other limited observations

No gross bile-duct dilatation or large-volume abdominal fluid collection is apparent on the reviewed images. These observations do not exclude small duct stones, subtle obstruction or other abdominal disease. The remaining organs require assessment in the formal report. [1]

Conclusion for clinical review

Tiny right hepatic focus, incompletely characterized; possible small cyst. Radiologist confirmation is required. Review the full DICOM examination and prior imaging before deciding whether any further assessment is needed. This document is an educational image summary, not a signed diagnostic report.

Interpretation and next steps

Why the spot remains uncertain

Small structures occupy only a few pixels. T2 images are 5–6 mm thick, while the dynamic T1 images are 3 mm thick. Motion and different breath-holds complicate matching. The diffusion images and ADC maps do not allow a dependable assessment of restriction within this tiny focus. [1]

“Observation” is an appropriate term when a true lesion cannot confidently be separated from a pseudolesion. Diffusion brightness must be interpreted with ADC; brightness alone does not identify the tissue type. [4]

What the medical references explain

A simple liver cyst generally has fluid-like T2 brightness, low T1 signal and no enhancing contents. Walls, septa, nodules and enhancement must be assessed before a cyst can be confidently classified. This general pattern explains the tentative cyst possibility here; it does not confirm it. [3]

Liver-lesion evaluation combines multiphase imaging with symptoms, prior cancer history, medication exposure, liver tests and hepatitis risk. [2] An unqualified LI-RADS category is not assigned in this review: the relevant risk history and diagnostic characterization are unavailable. LI-RADS is intended for defined populations at risk of hepatocellular carcinoma. [5]

MRCP coverage

Although “MRCP” appears in the study description, a dedicated heavily T2-weighted MRCP acquisition or duct reconstruction was not identified among the supplied series. The export cannot therefore be assumed to contain a complete duct examination. [1] MRCP is used to assess the biliary and pancreatic ducts as well as related organs. [6]

Practical follow-up

1. Obtain the signed report from the imaging centre and ask the radiologist to check the marked right-liver focus and its exact size and nature.
2. Provide earlier ultrasound, CT or MRI studies and the reason for this scan. Tell the clinician about hepatitis, cirrhosis or any previous cancer; bring available liver blood-test results.
3. Ask whether the focus is confidently benign or remains indeterminate. If an asymptomatic simple cyst is confirmed, guidelines generally do not recommend routine cyst follow-up. [3] That recommendation does not yet apply to this unconfirmed focus.

This review does not determine a need for biopsy, surgery, medication or a particular repeat-scan interval.

Seek urgent medical care for severe or persistent abdominal pain, especially with fever/chills, jaundice or repeated vomiting; dark urine and pale stools also need prompt assessment. [7]

مراجعة الرنين المغناطيسي للكبد

الملاحظة الأولية: تظهر بؤرة صغيرة جداً في الجزء الخلفي من الفص الأيمن للكبد في أكثر من تسلسل تصويري. وقد تمثل بؤرة صغيرة تحتوي على سائل، مثل كيس صغير، لكن هذا ليس تشخيصاً مؤكداً. لا تبدو كتلة كبدية كبيرة واضحة في الصور التي تمت مراجعتها. ولا يمكن بهذه المراجعة إثبات السرطان أو نفيه.

نوع الفحص	رنين مغناطيسي للبطن مع تسلسلات موسومة بمراحل متعددة بعد الصبغة؛ ويتضمن وصف الدراسة عبارة MRCP.
تاريخ الفحص والمصدر	14 سبتمبر 2026؛ المجلد المحلي Study0914083729048. [1]
الصور المتاحة	636 صورة بصيغة DICOM ضمن 12 سلسلة، بجهاز قوته 1.5 تسلا.
المعلومات السريرية	لم تُقدّم أسباب إجراء الفحص أو الأعراض أو التاريخ المرضي للكبد أو تحاليل الدم أو صور سابقة أو تقرير أشعة موقع.

النقطة 1: الجزء الخلفي من الفص الأيمن للكبد

تظهر بؤرة صغيرة مستديرة ذات إشارة مرتفعة في صور T2 المحورية، في السلسلة 3، الصورتين 8-9. وتبدو منخفضة الإشارة مقارنة بنسيج الكبد بعد الصبغة في السلسلة الموسومة بالمرحلة الوريدية، السلسلة 10، الصورتين 41-42، وفي السلسلة الموسومة بالمرحلة المتأخرة، السلسلة 12، الصورتين 41-42. تعتمد مطابقة الموضع على المعالم التشريحية، إذ يختلف وضع الكبد مع التنفس بين التسلسلات. [1]

يبدو حجم البؤرة أقل من سنتيمتر واحد. ولا يمكن اعتماد قياس دقيق أو رقم قطعة كبدية وفق تقسيم كوينو أو قياس دقيق للتعزز بالصبغة من هذه المراجعة. الكيس الصغير أحد الاحتمالات، لكن يجب على اختصاصي الأشعة استبعاد مقطع عرضي لوعاء دموي أو تأثير تداخل الأنسجة داخل الشريحة. تحدد الصورة التوضيحية موضع المراجعة، ولا تثبت العدد الكلي للآفات.

ملاحظات أخرى محدودة

لا يبدو توسع كبير واضح في القنوات الصفراوية أو تجمع كبير للسائل داخل البطن في الصور التي تمت مراجعتها. ولا ينفي ذلك حصوات صغيرة في القنوات أو انسداداً دقيقاً أو أمراضاً أخرى في البطن. وتحتاج بقية الأعضاء إلى التقييم ضمن تقرير الأشعة الرسمي. [1]

الخلاصة للمراجعة الطبية

بؤرة صغيرة جداً في الفص الأيمن للكبد، غير مكتملة التوصيف؛ قد تكون كيساً صغيراً، وتحتاج إلى تأكيد اختصاصي الأشعة. ينبغي مراجعة الفحص الأصلي كاملاً ومقارنته بالصور السابقة قبل تحديد الحاجة إلى أي تقييم إضافي. هذه مراجعة تعليمية للصور وليست تقريراً تشخيصياً موقعاً.

التفسير والخطوات التالية

سبب عدم الجزم بطبيعة البؤرة

تشغل البنى الصغيرة عدداً قليلاً من نقاط الصورة. تبلغ سماكة شرائح T2 نحو 5-6 ملم، وسماكة شرائح T1 الديناميكية 3 ملم. وتؤثر الحركة واختلاف حبس النفس في مطابقة الصور. لا تسمح صور الانتشار وخرائط ADC بتقييم موثوق لتقييم الانتشار داخل هذه البؤرة الصغيرة. [1]

يُفضّل وصف الموضع بأنه «ملاحظة تصويرية» عندما لا يمكن الجزم بأنه آفة حقيقية. كما يجب تفسير سطوع صور الانتشار مع خريطة ADC؛ فالسطوع وحده لا يحدد نوع النسيج. [4]

ما توضحه المراجع الطبية

يكون الكيس الكبدي البسيط عادةً مرتفع الإشارة مثل السائل على T2، ومنخفض الإشارة على T1، ولا تتعزز محتوياته بالصبغة. ويجب تقييم الجدار والحواجز والعقيدات والتعزز قبل تأكيد تصنيفه. يفسر هذا النمط العام احتمال الكيس هنا، لكنه لا يؤكد التشخيص. [3]

يعتمد تقييم البؤر الكبدية على التصوير متعدد المراحل مع الأعراض والتاريخ السابق للسرطان والأدوية وتحاليل الكبد ومخاطر التهاب الكبد الفيروسي. [2] لم تُمنح درجة LI-RADS في هذه المراجعة لعدم توفر التاريخ المرضي والتوصيف التشخيصي اللازمين. ويُستخدم هذا النظام لفئات محددة معرضة لخطر سرطان الخلايا الكبدية. [5]

مدى توفر صور القنوات الصفراوية

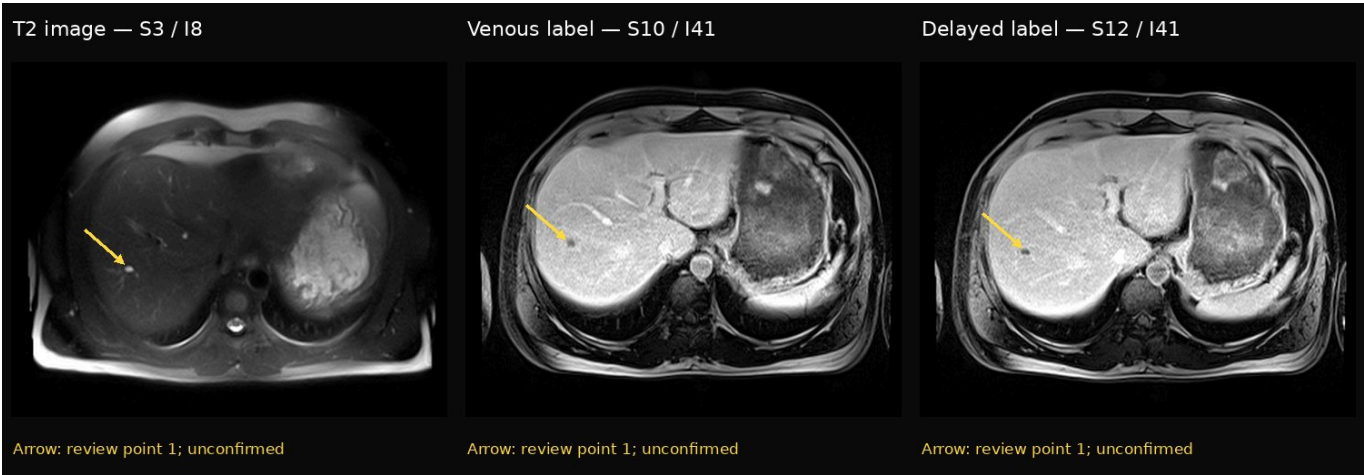
رغم ورود MRCP في وصف الدراسة، لم تُحدّد ضمن الملفات المرسلّة سلسلة مخصصة شديدة التوجيه بـ T2 لتصوير القنوات أو صور إعادة بناء خاصة بها. لذلك لا يمكن افتراض أن الملفات تتضمن فحصاً كاملاً للقنوات. [1] ويُستخدم MRCP لتقييم القنوات الصفراوية والبنكرياسية والأعضاء المرتبطة بها. [6]

المتابعة العملية

1. احصل على التقرير الموقع من مركز التصوير، واطلب من اختصاصي الأشعة مراجعة البؤرة المشار إليها وتحديد حجمها وطبيعتها.
 2. قدّم صور السونار أو الأشعة المقطعية أو الرنين السابقة وسبب إجراء هذا الفحص، وأخبر الطبيب عن أي التهاب كبد أو تشمع أو سرطان سابق، مع إحضار تحاليل الكبد المتاحة.
 3. استوضح هل البؤرة حميدة بشكل مؤكد أم لا تزال غير محددة. إذا تأكد أنها كيس بسيط لا يسبب أعراضاً، فلا توصي الإرشادات عادةً بمتابعة تصويرية روتينية للكيس. [3] ولا ينطبق ذلك بعد على هذه البؤرة غير المؤكدة.
- لا تحدد هذه المراجعة الحاجة إلى خزعة أو جراحة أو دواء أو موعد معين لإعادة التصوير.
- اطلب رعاية طبية عاجلة عند ألم بطني شديد أو مستمر، خاصةً مع الحمى أو القشعريرة أو اليرقان أو القيء المتكرر. كما يحتاج البول الداكن والبراز الفاتح إلى تقييم سريع. [7]

Image reference / موضع المراجعة

Point 1 is an unconfirmed review target. The arrows indicate the apparent corresponding tiny focus in the posterior right liver. These are displays derived from the supplied DICOM pixels; the original study remains the diagnostic source. [1]



Left: axial T2, S3/I8. Centre: venous-labelled T1, S10/I41. Right: delayed-labelled T1, S12/I41. Image display windows differ; brightness cannot be compared quantitatively across panels.

Reference	Appearance in this review
Series 3, images 8–9	Tiny bright T2 focus.
Series 10, images 41–42	Tiny dark focus relative to the enhanced liver.
Series 12, images 41–42	Persistent small dark focus on delayed-labelled images.

Patient right appears on the left side of these axial images. “S” means series; “I” means DICOM instance/image number. Equal image numbers or position values in different sequences do not guarantee the same anatomical slice.

شرح الصورة

النقطة 1 موضع للمراجعة وليست تشخيصاً مؤكداً. تشير الأسهم إلى البؤرة الصغيرة التي يبدو أنها متطابقة تشريحياً في الجزء الخلفي من الفص الأيمن للكبد. يمين المريض يظهر في يسار الصور المحورية.

الصورة اليسرى: السلسلة 3، الصورة 8، بترجيح T2. الوسطى: السلسلة 10، الصورة 41، الموسومة بالمرحلة الوريدية. اليمينى: السلسلة 12، الصورة 41، الموسومة بالمرحلة المتأخرة. تختلف إعدادات عرض السطوع بين الصور، لذلك لا تصلح للمقارنة الكمية للتعزز.

تختلف وضعية التنفس بين التسلسلات، ويجب تأكيد المطابقة في عارض الأشعة الأصلي. لا يثبت هذا الشكل حجم البؤرة بدقة أو طبيعتها أو العدد الكلي للبؤر. [1]

Study record and sources

Local imaging observations and medical background are different forms of evidence. References explain interpretation principles; they do not diagnose the marked focus. Web sources checked on 14 September 2026.

Study inventory / محتويات الدراسة

Series	Description	Images
1	Localizer / صور تحديد الموضع	14
2–3	Axial T2 HASTE / صور محورية T2	60
4	Coronal T2 HASTE / صور إكليلية T2	34
5	T1 dual echo / صدى مزدوج قبل الصبغة	60
6	Baseline T1 VIBE / T1 أساسي	72
7–8	Diffusion and ADC / الانتشار وخرائط ADC	120
9–10	Arterial- and venous-labelled T1 / مراحل موسومة بالشريانية والوريدية	144
11	Postcontrast T1 dual echo / صدى مزدوج بعد الصبغة	60
12	Delayed-labelled T1 / مرحلة موسومة بالتأخرة	72

Contrast-enhanced acquisitions are supported by series labels and visible enhancement. Contrast agent, dose and injection time are not documented in the inspected headers. A hepatobiliary phase and dedicated MRCP series were not identified in this export. [1]

Sources / المراجع

1. Local primary source: **Study0914083729048**, DICOM examination dated 14 September 2026, series 1–12. Private local files; no public URL. Key images: S3/I8–9, S10/I41–42, S12/I41–42. No signed report supplied.
2. [American College of Gastroenterology. Focal Liver Lesions: 2024 guideline highlights \(PDF hosted 2025\).](#) Clinical assessment and multiphase imaging.
3. [European Association for the Study of the Liver. Clinical Practice Guidelines on the management of cystic liver diseases. Journal of Hepatology 77 \(2022\): 1083–1108.](#) Cyst imaging features and follow-up after a confirmed diagnosis.
4. [Fowler KJ et al. Universal Liver Imaging Lexicon: Imaging Atlas for Research and Clinical Practice. RadioGraphics 43 \(2023\); published online 2022; corrected December 2022.](#) Observation terminology and diffusion interpretation.
5. [American College of Radiology. LI-RADS application FAQs. Updated 6 March 2020.](#) Appropriate risk population and conditional application.
6. [ACR/RSNA RadiologyInfo. MRCP \(MR Cholangiopancreatography\). Reviewed 15 June 2026.](#) Examination scope and radiologist reporting.
7. [National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Symptoms & Causes of Gallstones. Reviewed November 2017.](#) Symptoms requiring urgent assessment.